

Roteiros de vídeo

Treze roteiros para gravar o uso do sistema de ponta a ponta, do cadastro de um paciente ao painel da UTI. A área administrativa fica de fora.

Cada passo diz **o que clicar, o que digitar, o que falar e o que mostrar**. Os números que aparecem na tela foram conferidos no próprio sistema antes de entrar aqui.

Antes da primeira gravação

Leia uma vez. Vale para todos os vídeos.

ACESSO DE DEMONSTRAÇÃO

ENDEREÇO	http://localhost:5173/app/login
E-MAIL	nutricionista@demo.local
SENHA	Demo@Nutri2026
CLIENTE	Hospital Demonstração · usuária Ana Paula Martins, nível Administrador

Com esse acesso a barra lateral mostra só os módulos de negócio. O menu **Administração** e o seletor de clientes não aparecem.

NO DIA DE GRAVAR: ATUALIZE OS DADOS

O histórico foi criado em relação ao dia em que o script rodou. Sem atualizar, a ronda da tela inicial esvazia em uma semana. Com a API ligada, rode antes de gravar:

```
node demo/semear-demo.mjs --atualizar
```

Isso completa os dias que faltam até hoje nas internações em curso. Maria de Lourdes, Rosângela e Helena continuam com o dia de hoje **pendente**, de propósito: os vídeos 1, 6 e 10 dependem disso.

COMO DIGITAR NÚMEROS: A MÁSCARA DE CENTAVOS

Os campos numéricos se preenchem **da direita para a esquerda**, como numa caixa registradora: a vírgula se posiciona sozinha. Digite **só os algarismos, sem vírgula**. A coluna *Digite* dos roteiros já traz as teclas.

CAMPO COM 2 CASAS	TECLAS	APARECE	CAMPO COM 3 CASAS	TECLAS	APARECE
Peso 68 kg	6800	68,00	Peso do dia (pediatria)	9460	9,460
Altura do joelho 49 cm	4900	49,00	Calorias da fórmula láctea	66000	66,000
pH 7,41	741	7,41	Densidade da enteral	1250	1,250

Campos de número inteiro (idade, tomadas, PA, volume no acompanhamento pediátrico) não têm vírgula: digite o número como ele é. **Vale mostrar isso no vídeo**: é a primeira dúvida de quem usa.

ORDEM DE GRAVAÇÃO

Alguns vídeos usam o que o anterior cadastrou. A **Beatriz** nasce no vídeo 2 e volta nos vídeos 9 e 13. O **Gabriel** nasce no vídeo 5 e volta no 6. Grave nesta ordem; os demais vídeos usam pacientes que já estão no sistema.

1	Primeiro acesso e tela inicial	8	Calculadora de terapia nutricional
2	Cadastro de pessoa	9	Avaliação de UTI completa
3	Catálogos: fórmulas e produtos	10	Acompanhamento diário de UTI
4	Calculadora pediátrica	11	Painéis de terapia nutricional
5	Avaliação pediátrica	12	Ferramentas clínicas
6	Acompanhamento diário pediátrico	13	Fichas de anamnese e escalas
7	Painéis pediátricos e exportação		

SE PRECISAR REGRAVAR UM VÍDEO DE CADASTRO

O CPF é único no cliente. Se a Beatriz, o Roberto ou o Gabriel já foram salvos numa tentativa anterior, use um destes CPFs válidos na nova tentativa: **618.274.539-82** · **274.839.165-91** · **539.162.847-46** · **847.261.953-28** · **362.948.175-28** · **195.738.264-37**. Avaliações de UTI e dias de acompanhamento podem ser removidos pela própria lista (**Remover**).

Quem já está no sistema

30 pessoas, abril a outubro de 2026. Use estes pacientes quando o roteiro pedir dado pronto.

Pediatria — 9 crianças, cada uma com o seu responsável

CRIANÇA	SITUAÇÃO	BOM PARA MOSTRAR
Laura Fernandes Costa	3 avaliações (NAN 1 → NAN 2), internada por bronquiolite, 12 dias de acompanhamento	Curvas da OMS; mudou de faixa (peso adequado → acima do peso)
Miguel Oliveira Santos	Prematuro com APLV, PREGOMIN, 14 dias de acompanhamento	Painel de acompanhamento: ganho de peso dia a dia
Helena Rocha Lima	Cardiopata, INFATRINE, acompanhamento com hoje pendente	Fórmula hipercalórica; baixo peso
Arthur Pereira Gomes	Desnutrição, FORTINI, 2 avaliações	Recuperação: baixo peso → peso adequado
Sofia Almeida Barros	4 anos, excesso de peso, sem fórmula	Acima de 35 meses o sistema explica por que não calcula o VET
Davi, Valentina, Bernardo, Alice	NEOCATE LCD, NESTOGENO 2, NAN 1, NAN SL	Variedade de fórmulas no painel

Terapia nutricional — 12 adultos

PACIENTE	SITUAÇÃO	BOM PARA MOSTRAR
José Carlos Silveira, 72	Sepse; fase aguda → reabilitação; 20 dias, em curso	Painel do paciente com 2 avaliações; exames melhorando
Maria de Lourdes Becker, 81	AVC com disfagia; perda de 13 % em 3 meses; hoje pendente	Adesão abaixo de 70 % na tela inicial; vídeo 10
Antônio Marcos Vieira, 58	Pancreatite; IMC 45	Regra da obesidade substituindo a fase
Rosângela Pires Machado, 64	Hemodiálise contínua ; hoje pendente	Meta proteica renal; potássio alto; oligúria
Cláudia Regina Fontoura, 54	Cetoacidose diabética; admitida em 01/10	Progressão: dia 1 a 25 % da meta
Paulo Roberto Nascimento, 67	Sem peso nem altura; encerrado com alta	Peso e altura estimados pelo joelho
Luiz Fernando Kraemer, 45	Trauma com amputação de perna ; transferido	Peso corrigido por amputação
Terezinha, Eduarda, Sérgio, Ivo, Neusa	Internações encerradas (óbito, altas); Sérgio e Ivo com dieta intermitente	Histórico; régua OPAS (Terezinha)

Fichas — 19 preenchidas

NRS-2002 nas admissões da UTI (a da Neusa encerra na pré-triagem), MNA nos idosos, e anamneses adulto, hospitalar e pediátrica.

Vídeo 1 · Primeiro acesso e tela inicial

Cerca de 4 minutos · nada é cadastrado

OBJETIVO

Mostrar como entrar, como a tela inicial organiza o plantão e onde fica cada módulo.

1 Abra <http://localhost:5173/app/login>.

DIGA O acesso é liberado pelo administrador do sistema: não existe autocadastro. Cada hospital ou clínica tem o seu ambiente, e os dados de um nunca aparecem para outro.

2 Preencha **E-mail** e **Senha** e clique em **Entrar**.

DIGITE nutricionista@demo.local · Demo@Nutri2026

3 Pare na tela inicial, no painel **A ronda de hoje**.

DIGA A primeira coisa que o sistema responde é: o que precisa de mim hoje? A ronda lista os pacientes da UTI em acompanhamento e diz quem já teve o dia registrado.

MOSTRE 5 pacientes. Maria de Lourdes e Rosângela com **Pendente**; os outros com **Registrado**. Clicar numa linha pendente abre o registro do dia já com o paciente escolhido.

4 Desça até **Adesão abaixo de 70 %**.

DIGA Depois do sétimo dia de terapia, quem está recebendo menos de 70 % do prescrito aparece aqui. Nos primeiros dias a oferta baixa é a progressão, por isso o alerta espera.

MOSTRE Maria de Lourdes Becker, adesão média perto de 54 %, no 12º dia.

5 Mostre **Mudaram de faixa**.

DIGA Na pediatria o sistema compara as duas últimas avaliações de cada criança e avisa quando ela mudou de faixa na classificação da OMS, para melhor ou para pior.

MOSTRE Laura (peso adequado → acima do peso) e Arthur (baixo peso → peso adequado).

6 Mostre **Há mais tempo sem avaliação e Últimos 30 dias**.

DIGA E aqui, quem está há mais tempo sem ser reavaliado, e um resumo do último mês. Os painéis completos ficam em UTI em números e Pediatria em números.

7 Percorra a barra lateral, grupo por grupo.

DIGA Cadastros: pessoas e catálogos de fórmulas. Clínica: fichas de anamnese. Depois os dois módulos de cálculo, Pediatria e Terapia nutricional, cada um com calculadora, avaliações, acompanhamento diário e três painéis.

8 Clique no ícone de lua, no alto à direita.

DIGA Para o plantão noturno existe o tema escuro. A escolha fica guardada neste navegador.

MOSTRE A tela inteira escurece. Clique de novo para voltar ao claro.

9 Abra **Conta > Meu perfil**.

DIGA Em Meu perfil a própria nutricionista ajusta o nome e o telefone e troca a senha, com no mínimo 10 caracteres. E-mail e nível de acesso só o administrador muda.

10 Encolha a janela do navegador até a largura de um celular.

DIGA O sistema foi feito para ser usado à beira do leito, no celular. O menu vira uma gaveta e as tabelas viram cartões.

Fechamento. "No próximo vídeo vamos cadastrar um paciente."

Vídeo 2 · Cadastro de pessoa

Cerca de 6 minutos · cria a Beatriz (usada nos vídeos 9 e 13) e o filho dela

OBJETIVO

Cadastrar uma paciente completa, com endereço e contato, e ligar a ela um responsável cadastrado na hora, sem sair da tela.

1 Abra **Cadastros > Pessoas**.

DIGA *Pessoas guarda pacientes, responsáveis, profissionais e fornecedores. É um cadastro só: a mesma pessoa pode ser paciente e responsável ao mesmo tempo.*

MOSTRE A lista com os 30 cadastros. Digite **Costa** no filtro **Nome** para mostrar que a busca é instantânea, depois apague.

2 Clique em **Nova pessoa** e preencha **Identificação**.

DIGITE

CAMPO	VALOR
Tipo de pessoa	Pessoa física (já vem escolhido)
Nome	Beatriz Moura Andrade
CPF	48291573646 → aparece 482.915.736-46
RG	1087654321
Data de nascimento	12/03/1958
Sexo	Feminino

DIGA *A data de nascimento e o sexo não são detalhe de cadastro: é deles que o sistema tira a idade e as curvas de referência nas avaliações.*

3 Em **Classificação**, marque **Paciente**.

DIGITE Observação: Encaminhada pela equipe da emergência.

4 Em **Telefones**, clique em **Acrescentar**.

DIGITE Tipo: Celular · Número: 51987654321 → aparece (51) 98765-4321 · Principal: marcado

5 Em **E-mails**, clique em **Acrescentar**.

DIGITE Tipo: Particular · E-mail: beatriz.andrade@example.com

6 Em **Endereços**, clique em **Acrescentar**.

DIGITE

Tipo	Residencial	Cidade	digite Porto Ale e escolha Porto Alegre — RS
CEP	90430180 → 90430-180	Rua	Rua Mostardeiro
Número	780	Bairro	Moinhos de Vento
Complemento	Apto 302		

DIGA A cidade vem da base do IBGE: basta começar a digitar. Assim não existe "Porto Alegre" escrito de três jeitos diferentes.

7 Em **Vínculos**, clique em **Acrescentar** e depois no + ao lado de Pessoa.

DIGA O filho dela ainda não está no sistema. Não preciso sair daqui: o cadastro rápido resolve com o essencial, e o resto se completa depois.

DIGITE Cadastro rápido: Nome **Roberto Moura Andrade** · CPF 73160825426 · Tipo de cadastro: Responsável (já vem escolhido) · Telefone 51991234567 → **Cadastrar**

8 Complete a linha do vínculo.

DIGITE É o quê desta pessoa: Responsável · Observação: Filho

DIGA O vínculo vale nos dois sentidos: no cadastro do Roberto, a Beatriz aparece como dependente.

9 Clique em **Salvar**.

MOSTRE A Beatriz aparece na lista, com o telefone e a cidade.

10 Mostre o botão **Inativar** na linha da Beatriz, sem clicar.

DIGA Ninguém é apagado: quem não é mais atendido é inativado e some das buscas, mas o prontuário continua inteiro.

Fechamento. "A Beatriz vai aparecer de novo quando fizermos a avaliação de UTI e as fichas de anamnese."

Vídeo 3 · Catálogos: fórmulas e produtos

Cerca de 5 minutos · cria uma fórmula láctea e uma enteral próprias

OBJETIVO

Mostrar que o sistema já vem com as fórmulas do mercado, e como cadastrar um produto que o hospital usa e não está na lista.

1 Abra **Cadastros > Fórmulas lácteas**.

DIGA Estas dez vêm prontas, com o cadeado de "Do sistema". Elas valem para todos os clientes e não podem ser alteradas, para ninguém mudar sem querer a fórmula de que outro prontuário depende.

MOSTRE Clique numa fórmula do sistema: ela é somente leitura.

2 Clique em **Nova fórmula**.

DIGITE

CAMPO	TECLAS	APARECE
Nome	APTAMIL PROFUTURA 1	
Calorias (kcal / 100 ml)	66000	66,000
Proteína (g / 100 ml)	1300	1,300

DIGA A composição é a do rótulo, sempre por 100 ml. Confira na embalagem antes de salvar: é desse número que sai a oferta calculada.

3 Clique em **Salvar** e mostre o filtro **Origem > Minhas fórmulas**.

MOSTRE A fórmula nova aparece sozinha, sem o cadeado, com o botão Inativar.

4 Abra **Cadastros > Fórmulas enterais**; filtre **Categoria > Hiperproteica**.

DIGA Na enteral a composição é por litro, como vem no rótulo das fórmulas de sistema fechado. São 53 do sistema, separadas por categoria.

5 Clique em **Nova fórmula**.

DIGITE

CAMPO	TECLAS	APARECE
Nome	Nutrison Protein Plus	
Categoria	Hiperproteica	
Densidade (kcal / ml)	1250	1,250
Proteína (g / L)	63000	63,000
Carboidrato (g / L)	142000	142,000
Lipídio (g / L)	49000	49,000
Fibras (g / L)	15000	15,000

MOSTRE Ao preencher os macronutrientes aparece "**Confere**": o sistema soma as calorias dos macronutrientes e compara com a densidade.

DIGA Essa conferência pega o erro mais comum de digitação de rótulo: a composição de um frasco de 500 ml lançada como se fosse de um litro, ou uma vírgula no lugar errado.

6 Apague a densidade e digite 250 (fica 0,250). Mostre o aviso vermelho. Volte para 1250 e clique em **Salvar**.

7 Abra **Cadastros > Suplementos e módulos**; filtre **Tipo > Módulo proteico**.

DIGA Aqui ficam os suplementos orais, os módulos de proteína e os insumos da dieta artesanal, cada um com a medida do rótulo: colher, sachê, medidor. O módulo proteico é o que a avaliação de UTI sugere quando a dieta não fecha a meta de proteína.

MOSTRE Nutren Just Protein: medida de 15 g, 13 g de proteína, 52 kcal.

Fechamento. "Com o catálogo pronto, vamos ao primeiro cálculo."

Vídeo 4 · Calculadora pediátrica

Cerca de 4 minutos · nada é gravado

OBJETIVO

O cálculo rápido, sem paciente: estado nutricional, necessidade e quanto a dieta láctea cobre. O caso é o mesmo que valida o sistema.

1 Abra **Pediatria** > **Calculadora**.

DIGA A calculadora é para a conta de corredor: nada aqui vai para o prontuário. Para registrar, usamos a avaliação, que é o próximo vídeo.

2 Aba **Estado nutricional e necessidades**.

DIGITE

CAMPO	TECLAS	APARECE
Sexo	Feminino	
Idade (meses)	8	8
Peso (kg)	900	9,00

MOSTRE Peso para a idade: Peso adequado · VET 723 kcal/dia · Proteína 11 g/dia. No IMC, o sistema escreve que falta a estatura.

DIGA Nove quilos aos oito meses é exatamente o percentil 85 da OMS, o limite de cima da faixa adequada. E repare: sem estatura, o sistema não deixa o IMC em branco, ele diz o que falta.

3 Aba **Dieta láctea**.

DIGITE

CAMPO	TECLAS	APARECE
Fórmula láctea	NAN 2 (73,8 kcal · 1,65 g / 100 ml)	
Volume por tomada (ml)	11000	110,00
Frequência (horas)	300	3,00

DIGA Atenção na frequência: é o intervalo entre as mamadas, de 3 em 3 horas, e não quantas são por dia.

MOSTRE 8 tomadas por dia · 880 ml · 649,44 kcal · 14,52 g de proteína · adequação calórica 89,83 % · adequação proteica 132 %

4 Troque a frequência para 400 (4,00 h).

MOSTRE Tudo se recalcula sozinho: 6 tomadas, 660 ml, adequação calórica cai.

DIGA Não há botão de calcular: mudou um número, mudou o resultado.

5

Clique em **Imprimir**.

DIGA *A impressão não é a tela: é um demonstrativo, com os números já calculados e a referência de cada um ao lado. Depois clique em Limpar para começar outra conta.*

Fechamento. *"Agora vamos fazer a mesma conta para um paciente de verdade, e guardar no prontuário."*

Vídeo 5 · Avaliação pediátrica

Cerca de 5 minutos · cria o Gabriel (usado no vídeo 6) e a avaliação dele

A DATA DE NASCIMENTO DEPENDE DO DIA DA GRAVAÇÃO

O Gabriel precisa ter **exatamente 10 meses** no dia em que você gravar. Use o mesmo dia e mês de hoje, 10 meses atrás. Exemplos: gravando em 15/10/2026, nascimento **15/12/2025**; gravando em 03/11/2026, nascimento **03/01/2026**.

1 Abra **Pediatria** > **Avaliações** e clique em **Nova avaliação**.

2 Clique no + ao lado de Paciente.

DIGITE Cadastro rápido: Nome **Gabriel Souza Prado** · CPF 90527418323 · Data de nascimento: hoje menos 10 meses · Sexo: Masculino · Tipo de cadastro: Paciente → **Cadastrar**

MOSTRE O Gabriel já entra escolhido. **Sexo** e **Idade (meses)** = 10 se preenchem sozinhos, a partir do cadastro.

DIGA Ao escolher o paciente, o sistema puxa o sexo e calcula a idade em meses na data da avaliação. Se eu mudar a data, a idade acompanha.

3 Em **Profissional**, escolha **Ana Paula Martins**. Deixe a data de hoje.

4 Aba **Estado nutricional e necessidades**.

DIGITE

CAMPO	TECLAS	APARECE
Peso (kg)	940	9,40
Estatura (cm)	7350	73,50

MOSTRE IMC **17,40** · Peso para a idade: **Peso adequado** · Estatura para a idade: **Adequada** · IMC para a idade: **IMC adequado** · VET **758,6 kcal** · **Proteína 11 g**

DIGA Os três índices da OMS de uma vez, com a curva de zero a cinco anos. A necessidade energética segue as DRIs, de 2002.

5 Aba **Dieta láctea**.

DIGITE

CAMPO	TECLAS	APARECE
Fórmula láctea	NAN 2	
Volume por tomada (ml)	20000	200,00
Frequência (horas)	600	6,00

MOSTRE 4 tomadas · 800 ml · 590,4 kcal · 13,2 g · adequação calórica 77,83 % · adequação proteica 120 %

DIGA Aos dez meses a fórmula não é a única fonte: a criança já come papa. Os 78 % mostram o quanto a alimentação complementar precisa cobrir.

6 Aba **Observações**.

DIGITE Consulta de rotina. Introdução alimentar com boa aceitação de papas salgadas e frutas.

7 Clique em **Salvar** e depois em **Imprimir**.

MOSTRE A folha impressa: identificação, tira de indicadores, os três índices e a dieta com a procedência de cada número.

8 Volte à lista de avaliações e filtre **Paciente > Laura Fernandes Costa**.

DIGA Cada avaliação fica guardada com os números daquele dia. A Laura, por exemplo, tem três, e no painel do paciente vamos ver as três numa curva.

Fechamento. "Avaliação feita. Agora vamos registrar o que o Gabriel recebeu hoje."

Vídeo 6 · Acompanhamento diário pediátrico

Cerca de 5 minutos · registra o dia do Gabriel

ANTES DE GRAVAR

O vídeo 5 precisa estar feito. De preferência, grave no mesmo dia: o registro compara com a avaliação de hoje.

1 Abra **Pediatria** > **Acompanhamento diário**.

DIGA A avaliação define o plano. O acompanhamento diário registra o que de fato aconteceu: quanto a criança pesou e quanto ela aceitou.

MOSTRE A lista com os dias de Laura, Miguel e Helena: recebido sobre prescrito, adequação e aceitação.

2 Clique em **Novo dia**. Paciente: **Gabriel Souza Prado**. Data: hoje.

MOSTRE A caixa **Comparar com a avaliação de ...** aparece marcada, com 9,4 kg, 800 ml/dia e NAN 2.

DIGA O sistema encontra sozinho a avaliação mais recente, e é contra ela que mede o dia.

3 Preencha **O que foi medido e ofertado**.

DIGITE

CAMPO	TECLAS	APARECE
Peso do dia (kg, 3 casas)	9460	9,460
Volume prescrito (ml)	800	800
Volume recebido (ml)	760	760
Tomadas previstas	4	4
Tomadas aceitas	4	4
Observações	Aceitou bem as quatro mamadeiras.	

DIGA O peso do dia tem três casas, porque num lactente dez gramas fazem diferença.

4 Clique em **Registrar dia**.

MOSTRE Estado nutricional no dia: idade 10 meses, Peso adequado.

O que a criança recebeu: 95 % do prescrito · 560,88 kcal · 12,54 g · 59,29 kcal/kg · 1,33 g/kg · adequação calórica 73,94 % · proteica 114 % · tomadas aceitas 100 %

DIGA A classificação é feita com o peso de hoje e a idade de hoje, e não copiada da avaliação. Numa internação de um mês o lactente muda de linha na tabela da OMS, e o sistema acompanha.

5 Abra **Pediatria > Painel de acompanhamento** e escolha **Miguel Oliveira Santos**.

DIGA *Com vários dias registrados, o painel mostra a evolução. O Miguel, prematuro, tem duas semanas de acompanhamento.*

MOSTRE Resumo: dias registrados e variação de peso. **Crescimento:** o peso subindo dia a dia. **Oferta e adequação:** adesão e adequação calórica.

6 Clique em **Imprimir relatório**.

DIGA *O relatório do período vai para o prontuário ou para a equipe médica, com a tabela dia a dia.*

Fechamento. "No próximo vídeo, os painéis da pediatria."

Vídeo 7 · Painéis pediátricos e exportação

Cerca de 5 minutos · nada é cadastrado

- 1 Abra **Pediatria** > **Painel do paciente** e escolha **Laura Fernandes Costa**.

DIGA O painel do paciente responde: onde esta criança está hoje, e por onde andou.

MOSTRE Resumo: idade atual, três avaliações, a última com os três índices e a cobertura calórica.

- 2 Aba **Crescimento**.

MOSTRE As três avaliações sobre as curvas da OMS de peso, estatura e IMC para a idade.

DIGA Repare no último ponto do peso: ele saiu da faixa adequada. É a mudança que a tela inicial avisou. A Laura ganhou mais peso do que o esperado no último mês, e a observação da avaliação já pede para rever o volume.

- 3 Abas **Nutrição** e **Histórico**.

DIGA A cobertura nutricional no tempo, as fórmulas que ela usou (NAN 1 e depois NAN 2) e a tabela das avaliações. Imprimir histórico gera o resumo para a consulta.

- 4 Abra **Pediatria** > **Pediatria em números**.

MOSTRE 18 avaliações, 9 crianças, IMC adequado em cerca de 56 % das avaliações, avaliações por mês, estado nutricional pelos três índices, fórmulas mais prescritas, faixa etária e sexo.

DIGA É a visão do serviço: quantas crianças acompanhamos, como elas estão, quais fórmulas mais usamos. Dá para filtrar por período, por fórmula e por sexo.

- 5 Filtre **Fórmula láctea** > **NAN 2**; depois volte para Todas.

- 6 Clique num nome em **Crianças mais avaliadas**.

MOSTRE Abre o painel daquela criança.

- 7 Abra **Pediatria** > **Avaliações** e clique em **Planilha**; depois em **Relatório**.

DIGA Toda lista exporta. A planilha abre no Excel, e o relatório sai pronto para imprimir. O que vai para o arquivo é o filtro inteiro, não só a página que está na tela.

Fechamento. "Na sequência, o módulo de terapia nutricional do adulto."

Vídeo 8 · Calculadora de terapia nutricional

Cerca de 6 minutos · nada é gravado

OBJETIVO

Meta e prescrição de dieta enteral contínua para um adulto em fase aguda, e a hidratação. O caso é o mesmo que valida o sistema.

1 Abra **Terapia nutricional** > **Calculadora**. Aba **Antropometria**.

DIGITE

CAMPO	TECLAS	APARECE
Sexo	Masculino	
Idade (anos)	56	56
Altura (cm)	17200	172,00
Peso atual (kg)	6800	68,00

MOSTRE Peso considerado 68 kg (informado) · IMC 22,99 · Eutrofia (OMS 1997) · Peso ideal 65,08 kg. Os campos que faltam dizem o que pedem, por exemplo "Informe a circunferência do braço".

DIGA Com peso e altura medidos, o sistema usa os dois. No próximo vídeo vamos ver o paciente que não pode ser pesado.

2 Aba **Necessidades**.

DIGITE Fase da terapia: **Fase aguda** · Terapia renal substitutiva: **Nenhuma** · Meta na faixa: Máximo da faixa (já vem)

MOSTRE Faixa recomendada: **energia 1.020 a 1.360 kcal, proteína 81,6 a 102 g**. Meta adotada: **1.360 kcal e 102 g**.

DIGA Na fase aguda são 15 a 20 kcal por quilo e 1,2 a 1,5 grama de proteína por quilo. O sistema adota o máximo da faixa, e eu posso escolher o mínimo ou o ponto médio.

3 Mude **Meta na faixa** para Ponto médio, mostre a meta caindo e volte para Máximo.

4 Aba **Dieta enteral**.

DIGITE

CAMPO	TECLAS	APARECE
Fórmula enteral	Peptamen Intense (1 kcal/ml · 92 g PTN/L)	
Modo de infusão	Contínua (já vem)	
Vazão (ml/h)	6200	62,00
Horas de infusão	22,00 (já vem: a UTI desconta 2 h de pausas)	

MOSTRE Volume total 1.364 ml · 1.364 kcal · 125,49 g de proteína · 20,06 kcal/kg · 1,85 g/kg · 100,29 % da meta calórica · 123,03 % da meta proteica

DIGA Sessenta e dois mililitros por hora, em 22 horas, fecham a meta calórica. E como a fórmula é hiperproteica, a proteína passa da meta: não há lacuna para módulo, e o sistema diz isso.

5 Desça até a tabela **Progressão**.

MOSTRE Dia 1: 25 % (340 kcal, cerca de 15 ml/h) · dia 2: 50 % · dia 3: 75 % · dia 4: 100 % (1.360 kcal, cerca de 62 ml/h).

DIGA A dieta não começa cheia: a progressão em quatro dias já vem calculada, com a vazão de cada dia.

6 Aba **Hidratação**.

MOSTRE Necessidade mínima 1.700 ml e ideal 2.040 ml · água que a dieta já entrega 1.159,4 ml · água extra ideal 880,6 ml, e a tabela de como fracionar (por exemplo, 6 vezes de cerca de 147 ml).

DIGA De 25 a 30 ml por quilo. O sistema desconta a água livre que a própria fórmula já entrega e diz quanto falta, já dividido em horários.

7 Clique em **Imprimir** e depois em **Limpar**.

Fechamento. "E se o paciente não pode ser pesado nem medido? É o próximo vídeo."

Vídeo 9 · Avaliação de UTI completa

Cerca de 8 minutos · avaliação da Beatriz (do vídeo 2), sem peso e sem altura

O CASO

Beatriz, 68 anos, acamada na UTI, sem condições de ser pesada. Pesava 66 kg há três meses. Medidas à beira do leito: altura do joelho, braço, panturrilha e abdômen.

- 1 Abra **Terapia nutricional** > **Avaliações** > **Nova avaliação**. Paciente: **Beatriz Moura Andrade**. Profissional: **Rodrigo Mendes Teixeira**.

MOSTRE Sexo Feminino e Idade 68 se preenchem pelo cadastro.

- 2 Aba **Antropometria**: deixe **Altura** e **Peso atual em branco**.

DIGITE

CAMPO	TECLAS	APARECE
Etnia	Branca	
Altura do joelho (cm)	4900	49,00
Circunferência do braço (cm)	2650	26,50
Circunferência da panturrilha (cm)	3100	31,00
Circunferência abdominal (cm)	9200	92,00
Peso habitual (kg)	6600	66,00
Perdido em	3 meses	
Peso a usar no cálculo	Escolher automaticamente (já vem)	

MOSTRE Estimativas: altura estimada **158,23 cm**; peso por Chumlea 1988 **58,92**, Jung 2004 **56,02**, Rabito 2008 **59,62 kg**.

Diagnóstico: peso considerado **59,62 kg (Rabito 2008)**, altura considerada 158,23 cm (Chumlea 1985), **IMC 23,81**, Eutrofia pela OMS e **Eutrofia pelo idoso (Lipschitz 1994)**.

Perda de peso 9,67 % · Perda grave em 3 meses · Adequação da CB 84,39 % · Desnutrição leve · Panturrilha: Indicativo de depleção muscular.

DIGA Sem balança, o sistema estima a altura pela altura do joelho e o peso por três equações publicadas, e mostra todas. Em "escolher automaticamente" ele usa Rabito, validada na população brasileira, e eu posso trocar no seletor. O IMC diz eutrofia, mas a perda de quase 10 % em três meses e a panturrilha mostram o risco que o IMC esconde.

- 3 Mostre o seletor **Régua do idoso** (aparece porque ela tem mais de 60 anos).

DIGA A partir dos 60 anos o IMC também é lido pela régua do idoso. O padrão é Lipschitz, e a OPAS 2002 é a alternativa. É uma escolha, e não as duas lado a lado, porque elas discordam justamente na faixa do meio.

4 Aba **Necessidades**.

DIGITE Fase da terapia: **Fase aguda** · Terapia renal substitutiva: **Nenhuma**

MOSTRE Meta energética **1.192,4 kcal** · meta proteica **89,43 g**, calculadas sobre o peso estimado.

5 Aba **Dieta enteral**.

DIGITE

CAMPO	TECLAS	APARECE
Fórmula enteral	Fresubin 1.2 HP Fibre	
Vazão (ml/h)	4500	45,00
Horas de infusão	22,00	

MOSTRE 990 ml · 1.188 kcal (99,63 % da meta) · 59,4 g de proteína (66,42 %) · Proteína ainda em falta: 30,03 g.

DIGA As calorias fecham, a proteína não: faltam 30 gramas. Aumentar a vazão daria caloria demais. A saída é o módulo proteico.

6 Em **Módulo proteico**, escolha **Nutren Just Protein**.

MOSTRE Módulo proteico — Nutren Just Protein: **2,31 medidas por dia** · **34,65 g** · soma **120,12 kcal**.

DIGA O sistema diz quantas medidas do rótulo cobrem a lacuna, e quantas calorias o módulo acrescenta, para eu decidir se ajusto a vazão.

7 Aba **Hidratação**.

MOSTRE Mínima **1.490,5 ml** · ideal **1.788,6 ml** · a dieta entrega **792 ml** · água extra ideal **996,6 ml** (por exemplo, 6 vezes de cerca de 166 ml).

8 Aba **Observações**.

DIGITE Acamada, sem condições de pesagem. Peso e altura estimados. Perda grave em 3 meses; iniciar progressão em 4 dias com módulo proteico.

9 Clique em **Salvar** e depois em **Imprimir**.

MOSTRE A folha com a seção "Escolhas do cálculo": de onde saiu o peso, a régua usada, a fase e a posição na faixa.

DIGA A folha impressa registra não só os números, mas as escolhas que mudaram os números. Quem lê o prontuário sabe de onde saiu cada um.

Fechamento. "Avaliação salva. Agora o dia a dia: o acompanhamento diário."

Vídeo 10 · Acompanhamento diário de UTI

Cerca de 7 minutos · registra o dia da Maria de Lourdes e encerra o José

ANTES DE GRAVAR

Rode --atualizar no dia: a Maria de Lourdes precisa estar **Pendente** na ronda. O registro de hoje dela ainda não pode existir.

- 1 Na tela inicial, em **A ronda de hoje**, clique na linha da **Maria de Lourdes Becker**.

DIGA A ronda começa pela tela inicial: clique em quem está pendente e o registro do dia já abre com a paciente escolhida.

MOSTRE O formulário com a paciente, a data de hoje e "Comparar com a avaliação de 20/09/2026" marcado.

- 2 Aba **Dieta e TNE**.

DIGITE

CAMPO	TECLAS	APARECE
Dieta	Novasource Senior · SNE · 38 ml/h	
Volume prescrito em 24 h	83600	836,00
Volume recebido em 24 h	61000	610,00

MOSTRE O que de fato chegou: **72,97 % recebido · 756,4 kcal · 14,55 kcal/kg · 0,76 g/kg**.

DIGA O percentual é medido contra o que a avaliação prescreveu. A diferença entre prescrito e recebido é o que a tela inicial acompanha.

- 3 Aba **Laboratório**.

DIGITE

EXAME	TECLAS	APARECE	EXAME	TECLAS	APARECE
Potássio	390	3,90	Sódio	14200	142,00
Magnésio	190	1,90	Lactato	110	1,10
pH	741	7,41	pCO ₂	3900	39,00
Bicarbonato	2450	24,50	PCR	280	2,80
Glicemia (HGT)	16800	168,00			

DIGA Nenhum exame é obrigatório: registro o que saiu no dia. O sódio, que estava alto na internação, normalizou.

4 Aba **Clínica e balanço**.

DIGITE

CAMPO	TECLAS	APARECE
Suporte ventilatório	Cateter nasal	
PA sistólica / diastólica	136 / 78	136 / 78
Balanço hídrico (ml)	35000	350,00
Diurese (ml)	110000	1.100,00
Evacuação	1x pastosa	

MOSTRE Diurese por quilo: **0,88 ml/kg/h**.

DIGA O balanço aceita sinal de menos: quando é negativo, digite o menos antes dos números.

5 Abra a aba **Ingestão oral** só para mostrar.

DIGA Quando o paciente come pela boca, registro a aceitação de cada refeição em percentual. A Maria está em jejum oral pela disfagia, então fica em branco.

6 Aba **Observações e Salvar**.

DIGITE Dieta pausada por 5 h para ressonância de crânio.

MOSTRE Volte à tela inicial: a Maria passou para **Registrado**.

7 Abra **Terapia nutricional** > **Avaliações**, filtre Paciente **José** e abra a avaliação de **22/09/2026**.

DIGA O José foi extubado e está comendo. Ele sai da UTI hoje. Para ele sair da ronda, encerro o acompanhamento.

8 No painel **Acompanhamento** (acima das abas), preencha e clique em **Encerrar acompanhamento**.

DIGITE Encerrado em: hoje · Motivo: **Transferência** · Observação: Alta da UTI para a enfermaria da pneumologia.

MOSTRE "Encerrado em ... · Transferência". Na tela inicial o José sai da ronda.

DIGA Encerrar não apaga nada: todo o histórico continua nos painéis. E se foi engano, o botão **Reabrir acompanhamento** devolve o paciente à ronda.

DEPOIS DE GRAVAR

Se quiser o José de volta na ronda para outras gravações, clique em **Reabrir acompanhamento** na mesma avaliação.

Fechamento. "Com os dias registrados, os painéis mostram a evolução. É o próximo vídeo."

Vídeo 11 · Painéis de terapia nutricional

Cerca de 6 minutos · nada é cadastrado

1 Abra **Terapia nutricional** > **Painel do paciente** e escolha **José Carlos Silveira**.

MOSTRE Resumo: 72 anos, duas avaliações, peso de trabalho, IMC, metas e os dias registrados.

DIGA O José entrou em fase aguda, com sepse, e foi reavaliado dez dias depois, já em reabilitação. As metas subiram de 1.560 para 2.265 kcal.

2 Abas **Antropometria** e **Metas e oferta**.

MOSTRE O peso caindo de 78 para 75,5 kg entre as avaliações; energia e proteína, meta contra oferta.

3 Abra **Terapia nutricional** > **Painel de acompanhamento**, escolha o **José** e deixe **De** em branco (últimos 30 dias).

MOSTRE Resumo: dias registrados, adesão média, energia e proteína recebidas, balanço acumulado, diurese.

4 Aba **Dieta**.

DIGA Nos primeiros quatro dias a adesão sobe em degraus: é a progressão da dieta. Os dias com queda brusca têm a explicação na observação, como pausa para exame.

5 Aba **Laboratório**.

MOSTRE Os exames com a faixa de referência sombreada: **PCR caindo** de cerca de 22 para 3,5 mg/dL, **lactato normalizando** abaixo de 2, potássio voltando para a faixa de 3,5 a 5,0.

DIGA Cada exame é lido contra a sua faixa: a faixa aparece no gráfico, para não precisar lembrar o valor de referência.

6 Troque o paciente para **Rosângela Pires Machado** e abra **Laboratório** e **Balanço e hemodinâmica**.

MOSTRE Potássio começando acima de 5,0; diurese abaixo da linha de oligúria de 0,5 ml/kg/h; balanço negativo pela ultrafiltração.

DIGA A Rosângela está em hemodiálise contínua: diurese baixa é esperada, e o balanço é tirado pela máquina. Por isso a meta proteica dela é de 2 g/kg.

7 Abra **Terapia nutricional** > **UTI em números**.

MOSTRE 15 avaliações, 12 pacientes, 137 dias de acompanhamento, idade média em torno de 65 anos, adesão média em torno de 70 %, avaliações por mês, estado nutricional por três réguas, fórmulas prescritas, conduta (fase, terapia renal, modo de infusão) e os pacientes mais avaliados.

DIGA É o painel do serviço, para a gestão: volume de atendimento, perfil dos pacientes e adesão à dieta mês a mês. O aviso logo abaixo dos números explica que duas avaliações usaram a regra da obesidade, o que puxa a média de energia por quilo para baixo.

8 Clique em **Imprimir demonstrativo**.

Fechamento. *"Por último, as ferramentas de conferência da UTI."*

Vídeo 12 · Ferramentas clínicas

Cerca de 6 minutos · nada é gravado

1 Abra **Terapia nutricional** > **Ferramentas clínicas**, aba **Noradrenalina**.

DIGITE

CAMPO	TECLAS	APARECE
Peso (kg)	7000	70,00
Vazão da bomba (ml/h)	1000	10,00
Preparo	Simples — 2 ampolas em 250 ml	

MOSTRE Concentração 32 mcg/ml · dose 0,0762 mcg/kg/min.

DIGA A dose de droga vasoativa entra na decisão de iniciar ou progredir a dieta. A conta da bomba para mcg por quilo por minuto fica aqui.

2 Aba **Balanço nitrogenado**.

DIGITE Proteína ingerida em 24 h: 9000 → 90,00 · Ureia urinária de 24 h: 1800 → 18,00

MOSTRE Nitrogênio ingerido **14,4 g** · excretado **12,41 g** · balanço **+1,99 g** · **Balanço positivo** · **anabolismo**.

3 Aba **Propofol**.

DIGITE Vazão do propofol: 2000 → 20,00 · Horas de infusão: 24,00 (já vem)

MOSTRE 528 kcal/dia.

DIGA O propofol é uma emulsão lipídica: a 20 ml por hora são mais de 500 calorias por dia que não aparecem na dieta, e precisam ser descontadas da meta.

4 Aba Dieta artesanal.

DIGITE

CAMPO	TECLAS	APARECE
VET desejado (kcal)	200000	2.000,00
Peso (kg)	7500	75,00
Administrações por dia	4 (já vem)	
Base	Trophic basic pó · Doses da base: em branco	
Carboidrato · medidas	Carbodex	300 → 3,00
Proteína · medidas	Albumix power	200 → 2,00
Lipídio · medidas	Óleo de soja	50 → 0,50

MOSTRE Doses da base sugeridas **48,75 medidas/dia** · calorias totais **1.946,65 kcal** · **25,96 kcal/kg** · **1,23 g/kg** · distribuição sobre o ofertado **53,66 % / 19 % / 27,34 %** · água **1.789,39 ml, 447,35 ml** por administração.

DIGA Para quem recebe dieta em casa, em sistema aberto: com a base em branco, o sistema sugere as doses pelo VET. A distribuição aparece sobre o VET e sobre o que foi de fato ofertado, para a soma fechar em 100 %.

5 Desça até **Receita por administração e Embalagens estimadas por mês.**

MOSTRE Por administração: Trophic 12,19 medidas, Carbodex 0,75, Albumix 0,5, óleo 0,125. Por mês: Trophic 14,73 latas, Carbodex 1,86, Albumix 2,48, óleo 0,22 frasco.

DIGA É a receita que a família leva para casa, e quanto comprar por mês.

6 Clique em **Imprimir esta conferência.**

DIGA A impressão leva só a ferramenta que está aberta.

Fechamento. "No último vídeo, as fichas de anamnese e as escalas de triagem."

Vídeo 13 · Fichas de anamnese e escalas

Cerca de 8 minutos · três fichas da Beatriz (do vídeo 2) e um modelo próprio

1 Abra Clínica > Fichas de anamnese.

MOSTRE As fichas já preenchidas, com a coluna **Escore** (por exemplo, a MNA da Maria de Lourdes) e o **Preenchimento** "X de Y".

DIGA A ficha é dirigida por modelo: o sistema traz cinco prontos, a anamnese adulto, a pediátrica, a hospitalar, e duas escalas de triagem pontuadas, a MNA e a NRS-2002.

2 Nova ficha. Paciente: **Beatriz Moura Andrade**. Modelo da ficha: **NRS-2002 — Triagem de risco nutricional**.

3 Na **Pré-triagem**, marque **Não** nas quatro perguntas.

MOSTRE O painel conclui "**Sem risco na triagem inicial — repetir a triagem semanalmente**", e as seções Estado nutricional e Gravidade da doença ficam desabilitadas.

DIGA Na NRS, se nenhum dos quatro critérios está presente, a triagem termina aqui. O sistema desabilita as próximas etapas, para ninguém somar pontos que a escala manda não somar.

4 Agora responda a pré-triagem de verdade, e as duas etapas.

DIGITE

PERGUNTA	RESPOSTA
IMC menor que 20,5 kg/m ² ?	Não
Houve perda de peso nos últimos três meses?	Sim
Houve redução da ingestão alimentar na última semana?	Sim
Doença grave, por exemplo terapia intensiva?	Sim
Comprometimento do estado nutricional	Moderado — perda acima de 5 % em dois meses...
Gravidade da doença	Grave — paciente crítico...

MOSTRE Estado nutricional **2** · gravidade **3** · ajuste por idade **0** ("68 anos na data de preenchimento") · **escore 5 de 7** · **Em risco nutricional** · "Iniciar plano de terapia nutricional".

DIGA O ponto da idade, para 70 anos ou mais, o sistema calcula pela data de nascimento do cadastro. A Beatriz tem 68, então não soma.

- 5 **Salvar.** Depois **Nova ficha** para a Beatriz com o modelo **MNA — Mini Nutritional Assessment**. Responda a triagem (A a F).

DIGITE

RESPOSTA		RESPOSTA	
A	Diminuição moderada da ingestão	D	Sim
B	Entre um e três quilos	E	Sem problemas psicológicos
C	Deambula mas não é capaz de sair de casa	F	IMC de 23 ou mais

MOSTRE Triagem **9 de 14 · Sob risco de desnutrição**. O escore total espera a avaliação global.

DIGA Até 11 pontos na triagem, a MNA manda continuar para a avaliação global, e o painel avisa o que falta responder.

- 6 Responda a avaliação global (G a R).

DIGITE

G	Não	M	Três a cinco copos
H	Sim	N	Alimenta-se sozinho sem dificuldade
I	Não	O	Não sabe dizer
J	Três refeições	P	Pior
K	Duas respostas sim	Q	PB maior que 22
L	Sim	R	PP de 31 ou mais

MOSTRE Avaliação global **10 de 16 · escore total 19 de 30 · Sob risco de desnutrição**.

DIGA O escore é calculado enquanto respondo, e fica congelado na ficha salva: se alguém editar o modelo amanhã, a pontuação de hoje não muda.

- 7 **Salvar.** Depois **Nova ficha** com o modelo **Anamnese nutricional hospitalar**.

DIGITE

Via de alimentação atual *	Enteral por sonda
Está em jejum?	Não
Dieta prescrita atualmente	Fresubin 1.2 HP Fibre por SNE a 45 ml/h + Nutren Just Protein
Apresenta constipação? · disfagia? · inapetência?	Sim · Sim · Sim
Náusea, vômito, diarreia	Não
Tem alergias alimentares? · Quais?	Sim · Frutos do mar
Observações da equipe	Fonoaudiologia reavalia a deglutição em 48 h.

DIGA A pergunta com asterisco é obrigatória. As outras podem ficar em branco e são completadas depois.

8 **Salvar e Imprimir.**

MOSTRE A ficha impressa com as respostas por seção.

9 Abra **Cadastros auxiliares > Modelos de ficha** e abra **Anamnese nutricional adulto**. Clique em **Clonar para editar**.

DIGA *Os modelos do sistema não se editam. Para adaptar à rotina do serviço, eu clono: a cópia é minha e posso mudar à vontade.*

10 Na cópia, troque o nome e acrescente uma pergunta.

DIGITE Nome do modelo: **Anamnese nutricional — ambulatório** · **Adicionar pergunta:** Seção **Hábitos alimentares** · Pergunta **Usa adoçante?** · Tipo de resposta **Sim / Não** → **Salvar**

DIGA *E cada ficha guarda a pergunta como ela era no dia em que foi respondida. Se eu mudar o texto da pergunta depois, as fichas antigas continuam dizendo o que foi perguntado.*

Fechamento. "Esse foi o tour completo: cadastro, cálculo, avaliação, acompanhamento, painéis e fichas. Bom trabalho!"